

08 - 04.2- Troubles des conduites sexuelles - Pr. Adali

Bonjour à tous, et bienvenue à la conférence de presse de l'Assemblée nationale de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Université d'Ottawa. Elle est la plus grande université d'Ottawa.

Elle est la table stéthique de ses astrômes. Elle est la plus grande université d'Ottawa. Elle est la plus grande université d'Ottawa pour les persons deformés dans le modes.

Sur la taille des arbres, on peut T. pas de sexualité, comme ça le patient va déjà comprendre des parts que les troubles sexuels et l'asexualité, une bonne sexualité fait partie d'une bonne santé, d'accord ? Donc parler surtout sur le registre médical, bien sûr je ne vous demande pas d'utiliser un langage qui est très spécialisé par rapport à vos patients, d'accord ? Et poser des questions ouvertes, ne pas dire « est-ce que sexuellement ça va bien ? », la réponse ça va être oui ou non, mais « parlez-moi de votre sexualité par exemple ». Quand est-ce qu'il faut aborder, surtout dans des situations cliniques particulières, quand il y a des symptômes évoquant des troubles sexuels, notamment toute pathologie au niveau des organes génitaux chez la femme ou chez l'homme, toutes les infections génitales, quand le patient le demande, à la demande explicite du patient, et dans certaines situations cliniques aussi chez les patients qui ont des pathologies chroniques et qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. L'examen sexologique, est-ce qu'on a vu ça ? Parce que là c'est important. Examen sexologique, parce qu'il y a des sexologues qui font des examens sexologiques très spécialisés avec des techniques particulières, etc.

Ce n'est pas votre travail, ce n'est pas à vous de le savoir, mais il y a quand même un examen sexologique banal quand vous suspectez surtout des dysfonctionnements sexuels chez les patients. L'examen sexologique, c'est comme tout examen de tout organe ou de tout appareil que vous connaissez. Il est constitué d'une anamnèse détaillée du trouble.

Quand vous avez des céphalées, vous demandez à votre patient depuis quand il a ces céphalées, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants, est-ce qu'il y a des facteurs qui l'améliorent, est-ce que ces céphalées sont associées à autres symptômes, etc. C'est la même chose que pour le symptôme sexuel. Détailler aussi les signes somatiques associés, détailler les répercussions psychologiques ou les symptômes psychologiques associés.

Un patient qui vient pour un trouble de l'érection par exemple, et en même temps il a une humeur dépressive, vous pensez à quoi ? Baisse de la libido, un trouble sexuel dû à la dépression, ou bien non, les réflexes. Vous avez fait le cours des antidépresseurs ? Non. Les antidépresseurs peuvent donner des troubles de l'érection.

Vous devez penser à deux choses. C'est en fait ça, mettre le symptôme sexuel dans son cadre somatique, psychologique, etc. Donc ne pas traiter ou aborder le symptôme sexuel de façon isolée, mais il appartient à un contexte particulier.

Explorer l'avis sexuel du patient, la réponse sexuelle. Comment vous allez explorer la réponse sexuelle à votre avis ? La réponse sexuelle. Les trois phases de la sexualité.

Est-ce que la réponse sexuelle du patient ou de la sexualité antérieure, est-ce qu'il avait ce trouble-là depuis son enfance par exemple, depuis son jeune âge, depuis sa première expérience avec la sexualité, ou bien c'est un trouble sexuel qui est récent. Explorer aussi l'avis avec le partenaire. Est-ce que le partenaire il est aggravant ? Rappelez-vous, quand on a vu le rôle du partenaire, on avait vu que le partenaire peut être un facteur aggravant du trouble, oui ou non ? Ou bien le partenaire peut être un facteur qui va améliorer le trouble.

Dans quelle situation il va aggraver le trouble, le partenaire ? Si lui aussi il a un trouble sexuel, s'il est inexpérimenté, s'il est maladroit, etc. Donc c'est ça l'intérêt d'explorer la relation avec le partenaire dans le domaine sexuel. Parce qu'il se peut que, quoi que vous fassiez, même si vous traitez le patient de façon correcte, il y a toujours un partenaire qui viendra aggraver le trouble sexuel qu'il a. Ou bien au contraire, le partenaire est soutenant.

Antécédents, bien sûr, c'est normal. On avait vu qu'il y a des troubles sexuels qui sont d'origine organique, d'origine psychiatrique, qui sont dûs à des problématiques psychologiques temporaires, dû à un stress ou à un changement de mode de vie, et qu'après la disparition de ce facteur, tout va rentrer dans l'ordre. Examen somatique aussi, et orientation thérapeutique en fonction de l'éthiologie que vous suspectez, et en fonction aussi des moyens thérapeutiques.

Et en fonction de quoi encore ? Chose qui est très importante, le traitement est en fonction de quoi ? Pardon ? Non. De vos compétences, de ce que vous savez traiter. Parce que vous ne pouvez pas traiter tous les troubles sexuels, d'accord ? Les moyens thérapeutiques, la sexothérapie.

La sexothérapie c'est très spécialisé, c'est juste pour... Je donnerai des points rapides sur les principes de la sexothérapie. La sexothérapie elle est très intéressante quand vous avez des patients qui ont une anxiété de performance. Ce sont des patients qui ont tellement peur, ils sont anxieux par rapport à la performance sexuelle, qu'ils finissent par ne pas avoir de performance.

C'est comme l'éthique qui veut parler devant le public qui a un problème d'anxiété, qui a une phobie sociale par exemple, qui a le trac, et qui a peur de ne pas bien faire devant le public, et tellement il a peur qu'il va finir par ne pas bien faire, ne pas bien communiquer. C'est la même chose, d'accord ? La sexothérapie comporte une part très importante de l'information sur la sexualité. Vous vous rappelez de l'exemple que je vous ai donné de la personne qui ne savait pas de ce monsieur-là, qui ne savait même pas c'était quoi l'orgasme chez la femme, et qui est allée penser à des choses terribles.

Travailler aussi sur la communication dans le couple. Quand je dis la communication, ce n'est pas bonjour, bonsoir, est-ce que tu vas bien ? Non. La communication sur le registre de la

sexualité, de ne pas avoir de tabou entre couples pour parler de la sexualité, c'est très important, d'accord ? De parler de ce qui plaît au partenaire, de ce qui ne plaît pas au partenaire, quels sont ses problèmes, donc c'est ça, améliorer et encourager la communication.

Et c'est des exercices, des tâches assignées à domicile. Par exemple, je donnerai un exemple très simple, très facile, et puis on va passer. Si vous avez des patients qui ont des éjaculations précoces, d'accord ? Vous savez que dans le traitement de l'éjaculation précoce, le traitement psychothérapeutique de l'éjaculation précoce, il faut décentrer l'attention du patient, détourner son attention sur sa sensation sexuelle pure et plutôt centrer son attention sur ses sensations physiques, d'accord ? Donc pour qu'il ne soit pas très, comment dirais-je, très concentré sur le fait qu'il va éjaculer rapidement.

Ce qu'il faut en sexothérapie, en termes d'exercices, de tâches assignées à la maison par exemple, c'est de demander au couple de faire tous les préliminaires d'un acte sexuel, mais ne pas, et de, par exemple, pendant un certain moment, se focaliser sur telle ou telle sensation physique, pas sexuelle, pas au niveau des organes génitaux, mais physique, sur telle et telle sensation, voilà ce qu'il faut faire, et ne pas, ça ne doit pas se terminer par un acte sexuel, pour décentrer, pour apprendre au patient de ne pas se focaliser sur la sensation sexuelle pure et dure. Donc c'est juste une parenthèse, mais ce n'est pas votre travail, c'est le travail d'un bien formé. Pour les traitements médicamenteux, là vous pouvez aussi agir, les antidépresseurs, les anciens aussi, les nouvelles molécules agissent très bien sur l'éjaculation précoce, parce que, par un mécanisme inverse, parce que les antidépresseurs peuvent avoir comme effet secondaire un retard à l'éjaculation.

Donc ils sont utilisés, on utilise leur effet secondaire qui est le retard à l'éjaculation pour traiter l'éjaculation précoce. J'ai donné des exemples, voilà, devant une éjaculation prématurée, j'ai donné les bases du traitement, devant un dysfonctionnement érectile, dysfonction érectile, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant une impuissance sexuelle, l'information sur la sexualité, conseil d'hygiène de vie, c'est-à-dire éviter les excitants, éviter le tabac, une hygiène de santé correcte. Si c'est un patient diabétique, normaliser la glycémie, bien stabiliser le diabète.

Certains antidépresseurs peuvent donner des dysfonctions érectiles, donc il faudrait les changer, et on peut donner aux patients de façon ponctuelle des médicaments d'aide à l'érection. Tout ça, vous pouvez le faire en tant que médecin généraliste. Et aussi, j'ai donné l'exemple de comment traiter un trouble du désir chez la femme, et je passerai rapidement.

Les paraphilies, le souci avec les paraphilies, c'est la motivation du patient, parce que traiter un paraphile, c'est traiter un patient sous contrainte. Il est obligé, il a l'obligation de se faire traiter. De façon générale, c'est des patients qui sont emprisonnés pour des viols ou pour des necrophilies ou autre, et parmi les clauses du jugement, c'est l'obligation de soins psychiatriques.

Un paraphile viendra rarement, très peu, consulter, sauf si ce trouble-là commence à entraîner

une souffrance importante chez le patient ou chez son entourage. Je vous donne l'exemple d'un patient sadique avec son partenaire, ou un patient masochiste avec son partenaire. Les TCC, bien sûr.

Par exemple, pour un raptophile, violeur, les bases du traitement psychothérapeutique, c'est aider le patient à prendre conscience des conséquences de la paraphilie, mais surtout lui apprendre à éviter les occasions de la mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être à côté de... ne doit pas travailler, par exemple, dans une salle de sport dédiée uniquement aux femmes, par exemple. Si c'est un pédophile, il ne doit pas travailler dans des écoles ou dans des aires de jeu où il y a des enfants. Les traitements médicamenteux, on peut les utiliser, notamment les IRS, certains IRS, parce qu'ils ont une action, ils inhibent la libido, donc ça peut avoir un effet.

Et aussi le traitement hormonal, anti-androgénique, qui est très efficace pour la suppression des désirs, c'est aussi... ça peut être aussi une alternative. Vous, en tant que médecin généraliste, vous êtes les médecins de premier recours. Un patient qui a une dysfonction érectile ne viendra pas voir le urologue en premier, il viendra voir son médecin généraliste en premier.

Votre rôle, c'est de dépister déjà les dysfonctions sexuelles. Vous savez très bien, vous êtes maintenant bien formé sur comment faire un entretien sexologique, comment aborder la sexualité et dans quelle situation, d'accord ? Excusez-moi... Voilà, voilà. Donc faire la part dans le problème organique, problème psychiatrique ou une origine iatrogène, comme les médicaments, éduquer et informer sur la sexualité, encourager la communication saine du couple, enseigner des techniques, rappelez-vous, je vous ai donné trois exemples de techniques qu'on peut utiliser, qu'on peut enseigner aux patients qui ont différents troubles sexuels, et traiter, le mot clé, traiter en fonction de ses compétences, d'accord ? Savoir dire « je ne sais pas », savoir orienter le patient, savoir refuser un patient qui vient pour des troubles sexuels, même si ce sont des troubles bénins, oser refuser si vous ne savez pas traiter.

Ne me dites pas que « on a appris que les dysfonctions érectiles simples bénins, nous on peut les traiter », non. Si vous n'avez pas la compétence, si vous sentez que vous ne pouvez pas traiter, il n'y a aucun mal à orienter le patient chez un spécialiste, et on va passer au deuxième cours.